

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE III
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE CONSTANTINE
SERVICE D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

COURS DE 04^{ém} ANNEE DE MEDECINE

**Les maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin (MICI) :**

**PRESENTE PAR :DR. M. FERMAS
MAITRE DE CONFERENCE B**

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025/2026

PLAN :

I. Introduction :

II. Maladie de Crohn (MC):

A. Définition :

B. Epidémiologie et facteurs de risque :

C. Physiopathologie :

D. Diagnostic :

1. Clinique :

2. Biologie :

3. Endoscopie :

4. Imagerie :

5. Histologie :

E. Evolution :

F. Formes cliniques :

1. Forme symptomatique :

2. Forme topographique :

3. Forme selon la gravité :

4. Formes compliquées :

5. Formes anatomiques :

6. Formes évolutives :

7. Formes selon le terrain :

G. Traitement :

1. But :

2. Armes thérapeutiques :

3. Indications :

Recto-colite hémorragique (RCH):

A.Définition :

B.Epidémiologie et facteurs de risque :

C.Physiopathologie :

D.Diagnostic :

1. Clinique :
2. Biologie :
3. Endoscopie et imagerie:
4. Histologie :

E. Evolution :

F. Formes cliniques :

1. Forme topographique :
2. Forme selon la gravité :
3. Formes compliquées :
4. Formes selon le terrain :

E. Traitement :

1. But :
2. Armes thérapeutiques :
3. Indications :

VI. Colites inclassables (CI) :

V. Conclusion :

I. Introduction :

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) sont des affections inflammatoires chroniques de la paroi du tube digestif. Elles regroupent essentiellement trois entités à savoir la maladie de Crohn (MC), la recto-colite hémorragique (RCH) et un petit contingent de formes indéterminées : les colites chroniques inclassables (CI) dont la majeure partie sera finalement classée en RCH ou en MC.

II. Maladie de Crohn (MC):

A. Définition :

La maladie de Crohn (MC) est une affection chronique, d'étiologie inconnue, complexe et invalidante, résultant de l'interaction de facteurs génétiques, environnementaux et du microbiote intestinal. Cette pathologie, faisant partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) avec la recto-colite hémorragique (RCH), est observée principalement dans les pays occidentaux. Elle est définie par une inflammation digestive segmentaire et transmurale, elle est hétérogène dans son étiologie, sa physiopathologie, ses aspects cliniques et paracliniques, son évolution et sa prise en charge.

B. Epidémiologie et facteurs de risque :

La fréquence de la MC est plus importante en Europe et Amérique du Nord, même si elle augmente actuellement dans les pays en voie de développement. Il existe un gradient nord/sud en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'un gradient ouest/est en Europe.

L'incidence de la MC en Europe varie de 2 à 9 cas pour 100 000 habitants et par an et la prévalence de 8,3 à 250 cas pour 100 000 habitants, avec presque un million de personnes atteintes dans la communauté européenne.

En Algérie l'incidence varie entre 0,79 et 5,87 cas pour 100000 habitants et par an et la prévalence varie entre 11,80 et 43,50 pour 100000 habitants.

La MC survient à tout âge, avec un pic d'incidence entre 20 et 30 ans, même si 5 % des formes se déclarent après 60 ans et une légère prédominance féminine dans les pays à forte incidence.

Les facteurs favorisants représentés par :

- Les facteurs environnementaux : tabac, consommation d'alcool, l'appendicectomie, la prise de contraceptifs oraux, les habitudes alimentaires (saccharose, protéines animales et les acides gras poly insaturés), le stress et les facteurs psychologiques.
- Les facteurs génétiques : représentés par les gènes de susceptibilités (repose sur des observations d'agréations familiales, et notamment d'études chez les jumeaux).

C. Physio-pathologie :

La MC résulte de la survenue, dans la muqueuse digestive, d'une réponse inflammatoire anormale suscitée par une flore luminale à priori normale. Le rôle primordial de la flore intestinale est attesté en partie par le fait qu'il est pratiquement impossible d'établir une entérocolite expérimentale chez un animal axénique. Ainsi, les lésions semblent être le résultat d'une rupture de tolérance à la flore digestive, favorisée par des facteurs génétiques et environnementaux. Les maillons supposés de cet enchaînement consistent en des anomalies de la fonction de barrière de la muqueuse digestive et du système immunitaire muqueux.

D. Diagnostic : repose sur la conjonction d'arguments issus de

l'anamnèse, de l'examen clinique, des tests biologiques, des explorations endoscopiques, radiographiques et de l'histologie.

1. Clinique : les signes cliniques dépendent de la localisation, de la nature et de la sévérité des lésions touchant le tube digestif .

Elle touche classiquement le tube digestif de façon discontinue et transmurale, « de la bouche à l'anus », et peut s'accompagner de manifestations générales et extradigestives.

La maladie évolue en général par poussées d'intensité variable, entrecoupées de phases de rémission plus ou moins complètes et prolongées. Les signes cliniques sont souvent aspécifiques, expliquant le retard diagnostique.

La MC doit être recherchée en cas de :

- Diarrhée chronique (> 6 semaines).
- Douleurs abdominales inexpliquées associées à un syndrome inflammatoire inexpliqué.
- Anémie, des signes de malabsorption avec des carences vitaminiques.
- Retard staturopondéral, une altération de l'état général.

- Lésions proctologiques (fissures anales multiples, antérieures ou latérales, abcès péri-anal récidivant, fistules complexes),
- Signes généraux, ou extradiigestifs.
- Sténoses digestives qui se révèlent le plus souvent par un syndrome de König.
- Suppurations et abcès intra abdominaux (la conséquence des fistules internes).
- Lésions Ano-périnéales (LAP) : on distingue classiquement : les lésions primaires ou de type 1 d'origine inflammatoire (ulcérations et fissures) ; les lésions secondaires infectieuses ou de type 2, représentées par les suppurations aiguës ou abcès et les fistules ; et les lésions secondaires mécaniques ou de type 3, représentées par les sténoses. Les sténoses sont le plus souvent consécutives des lésions de type 1 ou 2, ou liées à l'inflammation chronique.
- Les manifestations extra-intestinales : représentées par les manifestations ostéo-articulaires (les arthropathies périphériques : pauci-articulaires ou polyarticulaires et les atteintes axiales avec notamment les spondylarthropathies), les atteintes dermatologiques (le Crohn métastatique, l'érythème noueux, l'aphtose buccale et le pyoderma gangrenosum), les manifestations ophtalmologiques (uvéïte, épisclérite, sclérite), les manifestations hépatobiliaires notamment la cholangite sclérosante primitive et rarement des atteintes cardio-vasculaires, pulmonaires, rénales ou neurologiques.

2. Biologie : l'anémie est fréquente lors du diagnostic (20 %) (ferriprive, inflammatoire, carentielle, hémolytique ou mixte), on peut retrouver également une thrombocytose, une hypoalbuminémie, des carences vitaminiques (folates, vitamine B12, vitamine D, etc.), une élévation de la protéine C-réactive (CRP) et des marqueurs fécaux de l'inflammation intestinale (calprotectine fécale et lactoferrine).

Les ASCA sont retrouvés dans près de 60 % des MC.

3. Endoscopie : les examens endoscopiques ont une place primordiale pour le diagnostic positif et différentiel des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour évaluer l'étendue et l'intensité des lésions, pour le pronostic, l'évaluation de la réponse au traitement et la surveillance de la dysplasie.

Les lésions dans la MC sont discontinues, « de la bouche à l'anus », espacées d'intervalles de muqueuse saine, hétérogènes et asymétriques.

L'iléocoloscopie avec biopsies : est l'examen de référence pour le diagnostic et l'évaluation de l'extension de la MC. Cet examen doit être réalisé dès la suspicion de MC, et avant la prise en charge thérapeutique.

L'aspect typique est une distribution segmentaire des lésions inflammatoires et ulcérées, souvent longitudinales, avec des intervalles de muqueuse saine, un aspect pavimenteux de l'iléon et/ou du côlon, la présence d'orifices fistuleux, de sténoses luminales, et une atteinte ano-périnéale. Ces lésions peuvent prendre la forme de lésions non ulcérées (érythème, aspect boursoufflé, œdémateux ou pavimenteux) ou d'ulcérations aphtoïdes, puis d'ulcérations étendues et serpigneuses, voire creusantes dans les formes sévères.

La réalisation de biopsies multiples au niveau des érosions et des lésions ulcérées augmente la probabilité de retrouver des granulomes, pathognomoniques de la MC, au moins deux biopsies sur chacun des six segments, au niveau des zones inflammatoires mais également au niveau des zones saines.

L'œso-gastro-duodénoscopie avec biopsies : est le plus souvent réalisée pour l'évaluation de l'extension de la maladie (en cas de signes cliniques du tractus digestif supérieur type nausées, vomissements, dyspepsie...) et pour le diagnostic différentiel (maladie cœliaque).

La vidéocapsule endoscopique : est recommandée en cas de suspicion diagnostique après normalité de l'iléocoloscopie. Sa sensibilité est supérieure aux examens en coupe (entéro-IRM et entéro-scanner), notamment pour les lésions muqueuses, et sa valeur prédictive négative est très élevée.

L'entéroscopie, poussée, simple ou double ballon par voie haute ou basse : peut être indiquée pour réaliser des biopsies en cas de doute diagnostique, ou pour des gestes thérapeutiques (dilatation de sténoses, retrait de capsule bloquée, hémostase).

4. Imagerie : les différentes méthodes d'imagerie sont complémentaires des examens endoscopiques pour le diagnostic de la MC, son extension, sa classification, la recherche de lésions sténosantes ou pénétrantes (fistules, abcès), et pour évaluer la réponse aux traitements, notamment en cas d'atteinte de l'intestin grêle ou de lésions ano-périnéales.

L'abdomen sans préparation (ASP) : abandonné.

L'échographie digestive : est un examen fiable, non irradiant, sensible pour l'examen de la région iléocœcale, du côlon droit, du côlon gauche et du sigmoïde, elle permet la détection de complications (fistules, abcès, phlegmons). L'utilisation de l'échographie de contraste augmente la sensibilité de cet examen.

L'entéroscanner : est un examen très sensible, mais l'irradiation doit limiter son utilisation (en urgence en cas de syndrome douloureux abdominal aigu, en cas de syndrome occlusif, en cas de complications postopératoires et aux drainages d'abcès).

L'entéro-IRM : actuellement remplace l'entéro-scanner, le seul avantage de ce dernier par rapport à l'IRM est la détection d'une perforation digestive. Sinon, les performances sont comparables pour mesurer l'activité de la maladie et détecter une destruction de la paroi intestinale (sténose, abcès, fistule).

C'est un examen de référence dans le bilan initial de la MC pour la détection de l'extension des lésions, la recherche de sténose, et l'atteinte pénétrante avec la recherche de fistules et d'abcès, notamment pour l'atteinte jéjunale et iléo-colique et pour le suivi non invasif des patients. Elle est également utile dans l'évaluation de la réponse aux traitements et peut être utilisée pour le diagnostic de la récurrence endoscopique en postopératoire.

L'IRM pelvienne et du canal anal : est l'examen de choix pour le diagnostic et la classification des lésions ano-périnéales, notamment des fistules, en complément de l'examen clinique sous anesthésie générale, avec une sensibilité supérieure à 90 %.

L'échographie endo-anale : peut-être une alternative à l'IRM, avec également une très bonne sensibilité pour les fistules, mais une moins bonne détection des abcès.

5. Histologie : les lésions les plus significativement associées au diagnostic histologique de MC sont une inflammation chronique (lymphoplasmocytose dans la lamina propria) focale ou irrégulière, une irrégularité focale de l'architecture des cryptes et des villosités et la présence de granulomes épithélioïdes et géantocellulaires, sans nécrose caséuse. La présence d'un granulome permet le plus souvent d'affirmer le diagnostic de MC. D'autres lésions comme la lymphocytose intraépithéliale, une inflammation transpariétale, une cryptite focale, une hypertrophie des filets nerveux et gastrite lymphocytaire focale sans *Helicobacter pylori* peuvent être retrouvées sur les biopsies ou sur les pièces opératoires.

E. Evolution :

La MC est une maladie chronique, évoluant par poussées entrecoupées de périodes de rémission, de gravité variable entre les individus, pouvant toucher n'importe quelle partie du tube digestif (« de la bouche à l'anus »), mais touchant principalement l'iléon terminal et le côlon.

La localisation initiale des lésions est déterminante pour les localisations ultérieures (la maladie touchant le plus souvent les mêmes segments au cours du suivi). La localisation de la maladie est habituellement stable au cours du temps. On distingue par ailleurs trois phénotypes ; les formes inflammatoires non sténosantes non pénétrantes, les formes sténosantes et les formes pénétrantes.

La maladie progresse au cours du temps sur le plan anatomique suivant les poussées inflammatoires, avec de plus en plus de lésions sévères sténosantes et pénétrantes, et une augmentation du risque de chirurgie, même si l'évolution est différente selon les patients.

F. Formes cliniques :

1. **Forme symptomatique** : notamment la forme pseudo-appendiculaire dont le tableau clinique simule une appendicite aiguë et le diagnostic de la maladie de Crohn est suspecté devant une diarrhée chronique.
2. **Forme topographique** : la forme stomatologique, la forme œsophagienne, la forme gastro-duodénale, la forme grélique, la forme colique et/ou ano-périnéale.
3. **Forme selon la gravité** : (annexes 01 et 02).
4. **Formes compliquées** : les complications sont représentées par : les sténoses digestives, la compression d'organes de voisinage, les fistules (ano-périnéales, recto-vaginales, entero- enterales, entero-cutanées, entero-vésicales), les abcès ano-périnéaux ou intra-abdominaux, la perforation, les hémorragies, l'incontinence, la dénutrition, le retard staturo-pondéral chez l'enfant, le grêle court après résections répétées et le cancer colique.
5. **Formes anatomiques** : représentées par les formes inflammatoires, les formes sténosantes et les formes pénétrantes.
6. **Formes évolutives** : représentées par les formes chroniques actives (continue: **absence de rémission malgré le traitement** ou intermittente : **poussées rapprochées et/ou interventions multiples**), les formes cortico-résistantes (maladie active malgré une corticothérapie jusqu'à 0,75 mg/kg/jour pendant 4 semaines) et les formes cortico-dépendantes (l'incapacité de réduire les corticoïdes sous l'équivalent de 10 mg/jour de prednisolone (ou sous 3 mg/jour de budesonide) dans les 3 mois suivant l'initiation du traitement, sans rechute de MC active ou bien rechute dans les 3 mois qui suivent l'arrêt des corticoïdes).
7. **Formes selon le terrain** : chez la femme enceinte, chez l'enfant et chez le sujet âgé.

G. Traitement :

1. But :

- Contrôler les poussées et améliorer la qualité de vie.
- Prévenir les rechutes et maintenir une rémission stable et prolongée.
- Diminuer le risque de complications liée à la maladie et à son traitement.

-Diminuer le recours aux hospitalisations et à la chirurgie.

2. Armes thérapeutiques :

- a. Règles hygiéno-diétiques : régime sans résidu stricte pendant les poussées.
- b. Traitement nutritionnel : correction des troubles hydro électrolytiques et vitaminiques.
- c. Traitement médical : les 5-ASA, les corticoïdes, les Immunosuppresseurs, les anti-TNF alpha, les anti intégrine alpha 4 beta 7, les anti IL12/23, les anti IL 23, les JAK Inhibiteurs et les antibiotiques.
- d. Instrumental et chirurgical : la colo-proctectomie/colectomie totale ou segmentaire, le drainage percutané et chirurgical des abcès, les dilatations pneumatiques, les résection, les structuro-plasties, les dérivations et la mise en place des sétos.

3. Indications : (annexes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11):

III. Recto-colite hémorragique (RCH):

A.Définition :

La recto-colite hémorragique ou ulcéro-hémorragique (RCH) appartient aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Elle est définie par un état inflammatoire chronique causant une inflammation continue de la muqueuse recto-colique sans granulome au niveau histologique, d'étiologie imparfaitement connue, atteignant constamment le rectum et, de manière variable, le côlon, sans intervalle de muqueuse saine. Elle évolue le plus souvent par poussées entrecoupées de rémissions.

B.Epidémiologie et facteurs de risque :

L'incidence et la prévalence de la RCH sont très variables en fonction de la localisation géographique, mais semblent plus importantes que dans la maladie de Crohn (MC). L'incidence annuelle de la RCH se situe aux alentours de 0,6 à 24,3/100 000 habitants et par an en Europe et de 4,9 à 248,6 en Amérique du Nord. L'incidence annuelle est plus faible en Asie et au Moyen-Orient, variant de 4,9 à 168,3/100 000 habitants et par an. La prévalence est élevée en Europe, variant de 4,9 à 505/100 000 habitants et en Amérique du Nord : de 37,5 à 248,6/100 000 habitants. Globalement, l'incidence de la RCH est en augmentation même si elle est plus marquée dans les pays en voie de développement et plutôt stable dans les pays industrialisés.

Un gradient Nord/Sud est classiquement décrit dans la RCH. Ce gradient pourrait être en partie expliqué par certains facteurs environnementaux (pollution, urbanisation, alimentation, etc.).

Les Caucasiens et les Israélites sont les plus touchés par la maladie. Les Hispaniques et les Asiatiques sont moins touchés, mais leurs incidences semblent en augmentation.

En Algérie l'incidence varie entre 1,07 et 3,29 cas pour 100000 habitants et par an et la prévalence varie entre 10,57 et 23,10 pour 100000 habitants.

Le pic d'incidence se situait entre 20 et 29 ans. Un second pic est inconstamment retrouvé aux alentours de 60 ans, mais la maladie peut apparaître à n'importe quelle période de la vie. La plupart des études ne retrouvaient pas de différence de prévalence entre les deux sexes ou tout au plus une légère prédominance masculine.

Les facteurs favorisants représentés par :

- Les facteurs environnementaux : l'amélioration des conditions de vie (réduisant les infections gastro-intestinales durant l'enfance, limiter la maturation du système immunitaire digestif), les infections gastro intestinales, l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et l'utilisation des contraceptifs oraux.

- Les facteurs génétiques : représentés par la présence d'antécédents familiaux de MICI, notamment pour les apparentés au premier degré.

Les facteurs protecteurs représentés par : le tabac, l'appendicectomie et l'allaitement supérieur à 03 mois.

C. Physio-pathologie :

À l'heure actuelle, malgré de nombreux travaux, la physio-pathologie de la RCH est encore imparfaitement connue. La théorie considérée comme la référence à ce jour serait une interaction entre le microbiote intestinal et le système immunitaire de l'hôte chez des patients prédisposés génétiquement et sous l'influence de facteurs environnementaux (Annexe : 12).

D. Diagnostic : est réalisé à l'aide d'un faisceau d'arguments

cliniques, endoscopiques et histologiques. Une cause infectieuse doit toujours être exclue. À noter que dans près de 10 % des cas, le diagnostic est redressé pour une MC dans les cinq ans qui suivent le diagnostic.

1. Clinique : La présence de sang dans les selles est retrouvée dans près de 90 % des

cas. Les signes cliniques associés dépendent de l'extension de la maladie.

Une diarrhée chronique permet de différencier la RCH des colites infectieuses. Les patients souffrant d'une maladie étendue présentent le plus souvent une diarrhée chronique associée presque invariablement à des rectorragies ou la présence de traces de sang dans les selles.

On retrouve parfois des impériosités, des ténésmes, des douleurs abdominales, des selles nocturnes, des selles glaireuses ou une douleur de la fosse iliaque gauche soulagée par la défécation. A contrario, les patients atteints de rectite décrivent principalement des

rectorragies, un syndrome rectal associant ténésme et impériosité et parfois une constipation terminale. Le début de la maladie est souvent insidieux, mettant plusieurs semaines ou plusieurs mois à devenir symptomatique. La maladie évolue par poussées et la RCH se révèle par une poussée sévère dans environ 15 % des cas, caractérisée par des signes cliniques de retentissement systémique tels qu'une perte de poids, une fièvre, une tachycardie parfois même des nausées ou des vomissements.

Les manifestations extra-intestinales : représentées par :

- Les manifestations rhumatologiques : arthralgies, arthrites périphériques ou axiales, spondylarthrite ankylosante, ostéoporose, ostéonécrose, etc.
- Les manifestations cutanées : érythème noueux, pyoderma gangrenosum (PG), aphtes buccaux.
- Les manifestations ophtalmologiques : épisclérite, sclérite, uvéite, conjonctivite, etc.
- Les manifestations hépato-biliaire : cholangite sclérosante primitive, hépatites auto-immunes, stéatose hépatique, etc.
- Les manifestations hématologique : anémie inflammatoire ou par carence martiale.
- Les manifestations thrombo-emboliques.

2. Biologie : une numération-formule sanguine (NFS), permettant de révéler une anémie (carence martiale et inflammation) ou une thrombocytose en rapport avec l'inflammation chronique, un ionogramme sanguin avec évaluation de la fonction rénale, un bilan hépatique complet et la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique (CRP). Un examen des selles est indispensable afin d'éliminer une cause infectieuse. En fonction du contexte clinique, des examens supplémentaires peuvent être réalisés, notamment à la recherche d'une amibiase ou d'autres parasites. Une recherche de surinfection par le cytomégalovirus (CMV) doit être recherchée en cas de poussée sévère.

Les pANCA sont retrouvés dans près de 60 % des RCH.

3. Endoscopie et imagerie: l'iléo-coloscopie avec biopsies segmentaires incluant

le rectum reste le gold standard pour établir le diagnostic. Elle permet, dans le même temps, d'évaluer l'étendue de l'atteinte. En cas de poussée sévère, une recto-sigmoïdoscopie souple suffit pour évaluer la gravité et une radiographie de l'abdomen sans préparation est recommandée afin de rechercher une colectasie.

Une fibroscopie œsogastroduodénale n'est recommandée qu'en présence de symptômes digestifs hauts. La colo-IRM pourrait être particulièrement utile dans le cadre du suivi de biothérapies. L'utilisation du colo-tomodensitométrie (TDM) est limitée par son caractère irradiant.

L'atteinte endoscopique débute invariablement juste au-dessus de la marge anale et remonte de manière proximale. L'atteinte est continue avec une limite supérieure des lésions nettement définie. Les principales lésions dans les formes légères sont représentées par un érythème, une muqueuse congestive et une diminution de la vascularisation. On retrouve une muqueuse granitée saignant au contact avec des érosions dans les formes modérées.

Enfin, on retrouve des ulcérations avec une muqueuse saignant spontanément dans les formes sévères. Les ulcérations profondes sont de pronostic péjoratif. Une évolution longue de la maladie peut entraîner une cicatrisation pathologique de la muqueuse avec une perte des haustrations, la présence de sténoses ou de pseudopolypes.

4. Histologie : schématiquement, on distingue les modifications architecturales (bifurcations cryptiques, des distorsions cryptiques, une atrophie cryptique et une irrégularité de surface), les anomalies épithéliales (perte de la mucosécrétion par diminution en nombre des cellules caliciformes ou d'une diminution de la mucine intracellulaire) et les caractéristiques inflammatoires (plasmocytose à la base des cryptes, abcès cryptiques).

E. Evolution :

La RCH évolue le plus souvent par poussées entrecoupées de périodes de rémission. Au moment du diagnostic, 10 % des RCH se présentent sous formes sévères, tandis que la plupart sont des formes légères ou modérées. L'extension de la maladie peut augmenter au cours du temps.

F. Formes cliniques :

1. **Forme topographique :** la forme rectale, la forme, colique gauche, la forme pancolique, la formes épargnant le rectum, la forme avec une atteinte discontinue du cæcum, la forme avec atteinte appendiculaire et la forme avec iléite de reflux .
2. **Forme selon la gravité :** (annexes 13 et 14).

3. **Formes compliquées** : représentées par : les sténoses coliques, la colectasie, le méga-colon toxique, les hémorragies graves, la dysplasie et les cancer colo-rectaux.
4. **Formes évolutives** : représentées par les formes chroniques actives, les formes cortico-résistantes et les formes cortico-dépendantes.
5. **Formes selon le terrain** : chez la femme enceinte, chez l'enfant et chez le sujet âgé.

G. Traitement :

1. But :

- Contrôler les poussées et améliorer la qualité de vie.
- Prévenir les rechutes et maintenir une rémission stable et prolongée
- Diminuer le risque de complications liée à la maladie et à son traitement.
- Diminuer le recours aux hospitalisations et à la chirurgie.

2. Armes thérapeutiques :

- a. **Règles hygiéno-diétiques** : régime sans résidu strict pendant les poussées.
- b. **Traitement nutritionnel** : correction des troubles hydro électrolytiques et vitaminiques.
- c. **Traitement médical** : les 5 amino-salicylés (5-ASA), les corticoïdes, les Immunosuppresseurs type azathioprine, les anti-TNF alpha, les anti integrine alpha 4 beta 7, les anti IL12/23, les anti IL 23, les JAK Inhibiteurs, les modulateurs de S1P et les antibiotiques.
- d. **Chirurgical** : la coloproctectomie/colectomie totale.

3. Indications : (annexes 15 et 16).

VI. Colites inclassables (CI) :

Elles représentent une entité particulière, un sous-groupe de colites inflammatoires chroniques n'ayant pas encore une place bien définie dans la Classification Internationale des Maladies. Elle a longtemps été considérée comme un diagnostic purement histo-pathologique, mais au fil du temps, elle a occupé une place importante, car un assez grand nombre de patients ne pouvaient être considérés atteints ni d'une maladie de Crohn ni d'une RCH, et cela même après un examen anatomo-pathologique complet d'une pièce de colectomie.

En effet et malgré la présence de signes évidents de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, il n'existe aucun critère propre à l'un ou à l'autre de deux pathologies : MC et RCH.

V. Conclusion :

Les MICI sont des maladies chroniques évoluent par poussées entrecoupées de rémissions.

Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments : clinique, biologique et morphologique .

Devant toute MICI il faut évaluer sa sévérité, faire un bilan topographique, rechercher les LAP et les manifestations extra-intestinales.

Une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire précoce et un suivi adapté et rapproché en mesurant les signes objectifs d'inflammation intestinale sont indispensables pour limiter l'évolution vers les complications et permettre un retour à une vie normale sans handicap fonctionnel chez les patients avec une MICI.

Une escalade thérapeutique rapide reste la règle chez la majorité des patients, même si l'introduction précoce d'un anti-TNF peut être discutée en cas de MICI sévère et/ou compliquée.

	j1	j2	j3	j4	j5	j6	j7	Somme	Coefficient multiplicateur	Total
Nombre de selles liquides ou molles									2	
Douleurs abdominales :									2	
• absentes = 0										
• légères = 1										
• moyennes = 2										
• intenses = 3										
Bien-être général :									2	
• bon = 0										
• moyen = 2										
• médiocre = 3										
• mauvais = 4										
• très mauvais = 5										
Autres manifestations :										
- arthrites ou arthralgies									20	
- iritis ou uvéïte									20	
- érythème noueux, pyoderma, aphtes buccaux									20	
- fissures, fistules, abcès anal ou périrectal									20	
- autre fistule intestinale									20	
- fièvre (>38° dans la semaine)									20	
Traitement antidiarrhéique									30	
(lopéramine ou oplacés) :										
• non = 0										
• oui = 1										
Masse abdominale :									10	
• absente = 0										
• douteuse = 1										
• certaine = 5										
Hématocrite ^a :									6	
• homme : 47 - hématocrite										
• femme : 42 - hématocrite										
Poids ^a :										
100 × (1 - poids actuel/poids théorique)										

^a Le signe doit être conservé donc ajout ou soustraction.

Annexe : 01

	Valeur
Bien-être général :	
• bon = 0	
• moyen = 1	
• médiocre = 2	
• mauvais = 3	
• très mauvais = 4	
Douleurs abdominales :	
• absentes = 0	
• faibles = 1	
• moyennes = 2	
• intenses = 3	
Selles liquides : nombre/jour	
Masse abdominale :	
• absente = 0	
• douteuse = 1	
• certaine = 2	
• certaine avec défense	
Signes extradiigestifs, fistule, fissure anale : 1 point par item présent	
Score (= somme)	

Annexe : 02

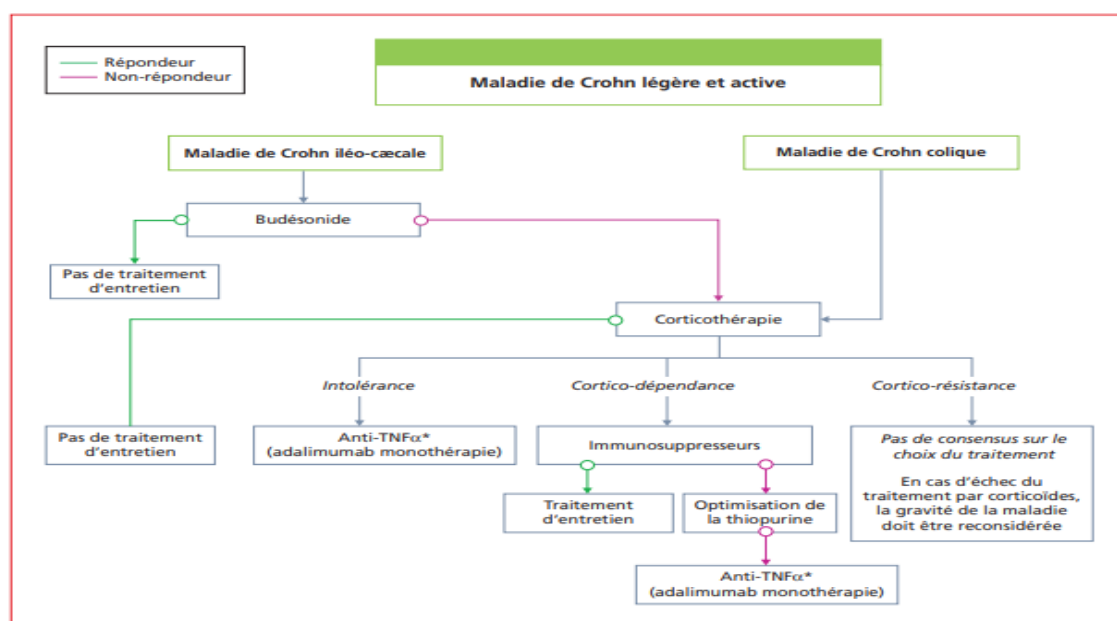


Figure 1 • Maladie de Crohn légère, active et non compliquée. Algorithme thérapeutique pour une première poussée avec un indice de Harvey-Bradshaw < 8 et sans facteur de mauvais pronostic. *L'anti-TNFα n'est pas indiqué pour la maladie de Crohn légère ; TNFα, facteur de nécrose tumorale alpha.

Annexe : 03

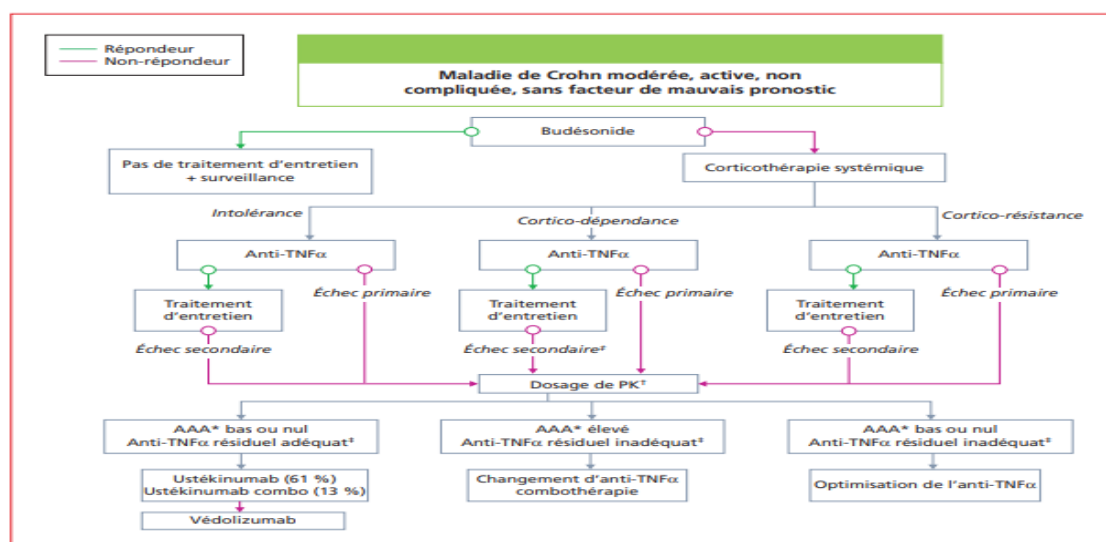
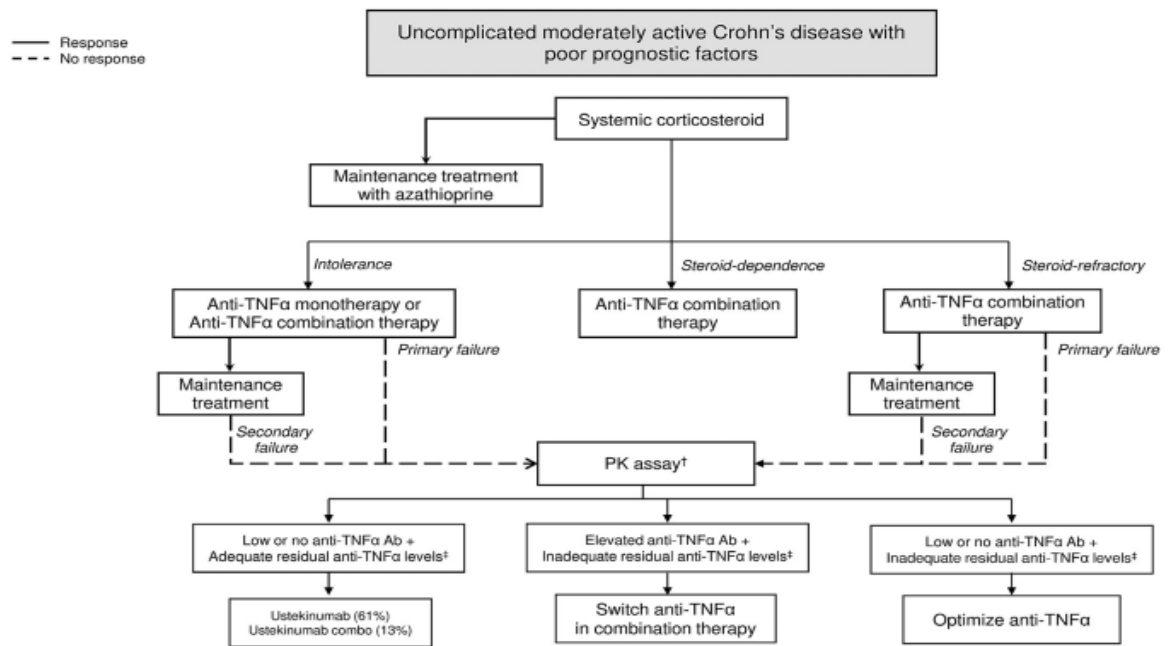


Figure 2 • Maladie de Crohn modérée, active et non compliquée sans facteur de mauvais pronostic. Algorithme thérapeutique pour une première poussée chez un patient naïf de traitement et présentant une atteinte iléocolique droite. ¹En l'absence de test pharmacocinétique : l'ustékinumab est l'alternative thérapeutique lorsque les effets indésirables du traitement anti-TNFα (paradoxaux ou non paradoxaux) conduisent à l'arrêt du traitement ou après échec primaire du traitement anti-TNFα. Après échec secondaire du traitement anti-TNFα, aucun consensus sur le traitement n'a été atteint. ²Le seuil d'optimisation est de 10 µg/mL pour l'infliximab et l'adalimumab. Les facteurs de mauvais pronostic ont été définis comme des lésions gastro-intestinales supérieures, des lésions de l'intestin grêle, une atteinte iléale sévère, une atteinte rectale sévère, des lésions périanales, des lésions sévères à l'endoscopie (ulcère large et/ou profond) et un jeune âge au moment du diagnostic. *AAA : anticorps anti-anti-TNFα ; PK, pharmacocinétique ; TNFα, facteur de nécrose tumorale alpha.

Annexe : 04



Ab, antibody; PK, pharmacokinetic; TNFα, tumor necrosis factor alpha. Anti-TNF refers either to intravenous or subcutaneous anti-TNF.

Annexe : 05

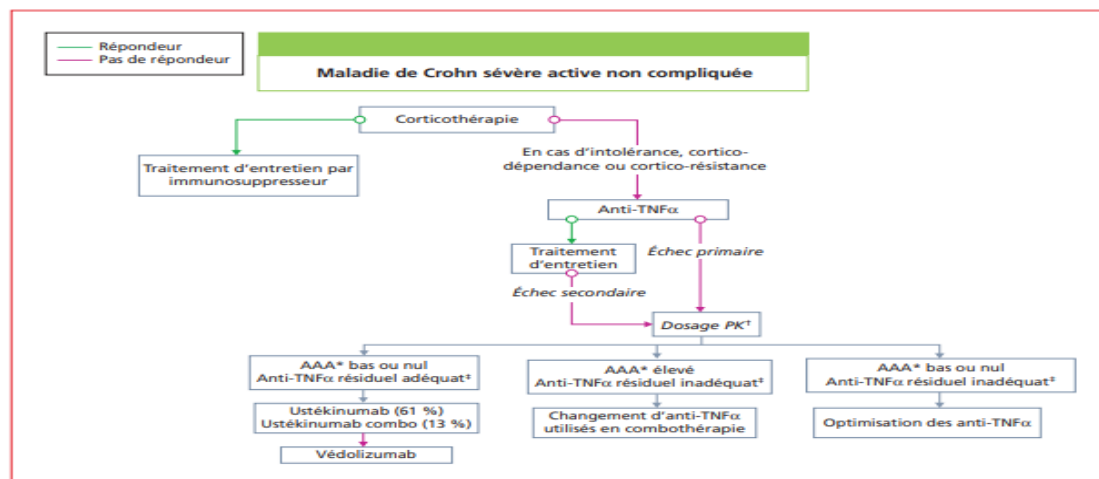


Figure 6 • Maladie de Crohn sévère évolutive et non compliquée. Algorithme thérapeutique pour une première poussée chez un patient naïf au traitement et présentant une atteinte iléocolique droite. †En l'absence de test pharmacocinétique : l'ustékinumab est l'alternative thérapeutique lorsque les effets indésirables du traitement anti-TNFα (paradoxaux ou non paradoxaux) conduisent à l'arrêt du traitement ou après échec primaire du traitement anti-TNFα. Après échec secondaire du traitement anti-TNFα, aucun consensus sur le traitement n'a été atteint. ‡Le seuil d'optimisation est de 10 µg/mL pour l'infliximab et l'adalimumab. Ab, anticorps ; PK, pharmacocinétique ; TNFα, facteur de nécrose tumorale alpha. *AAA : anticorps anti-anti-TNFα.

Annexe : 06

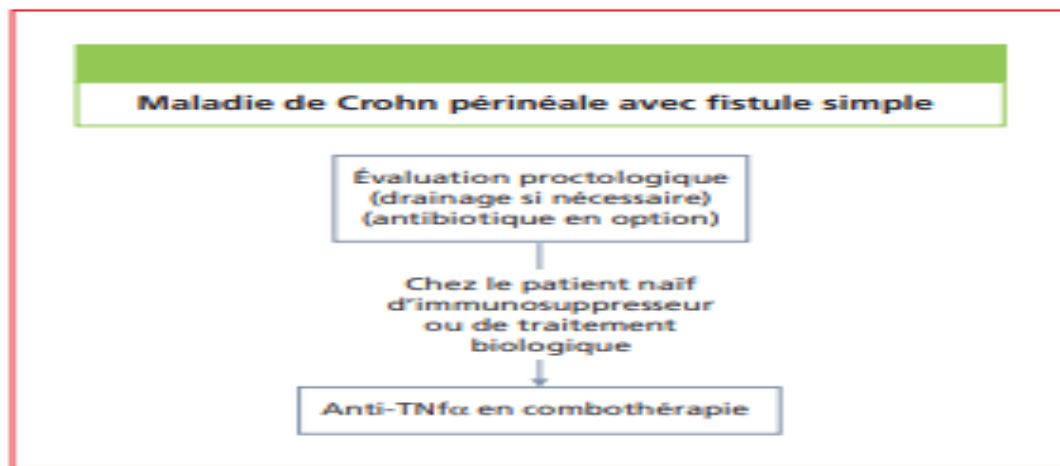
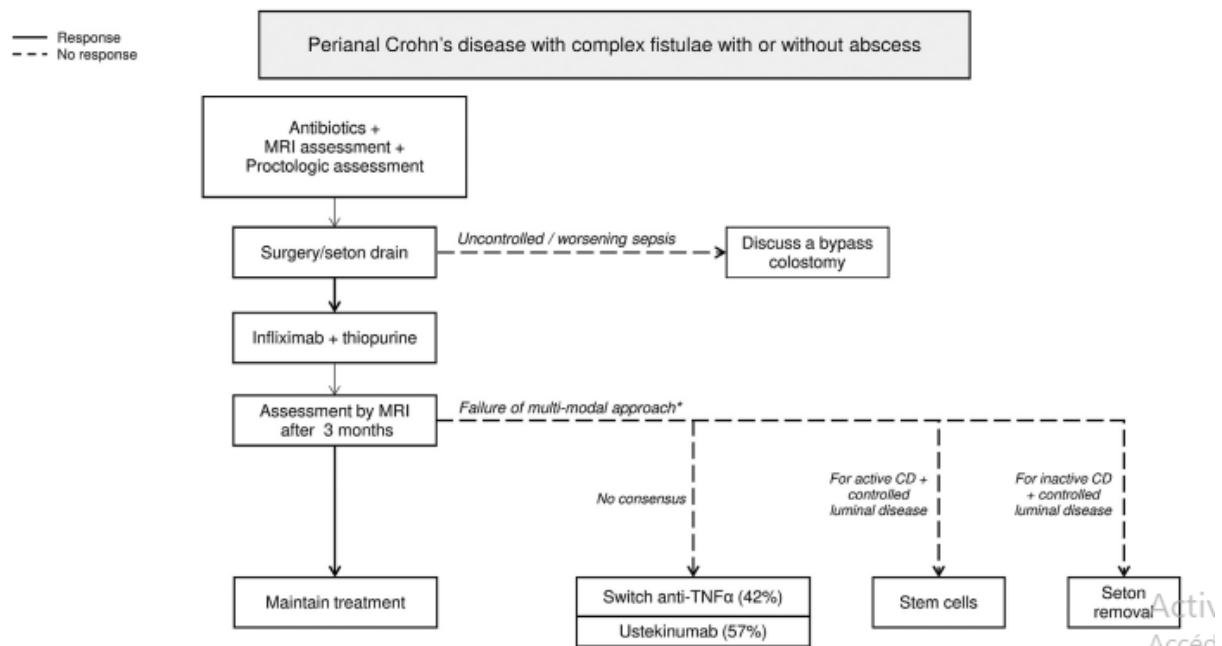
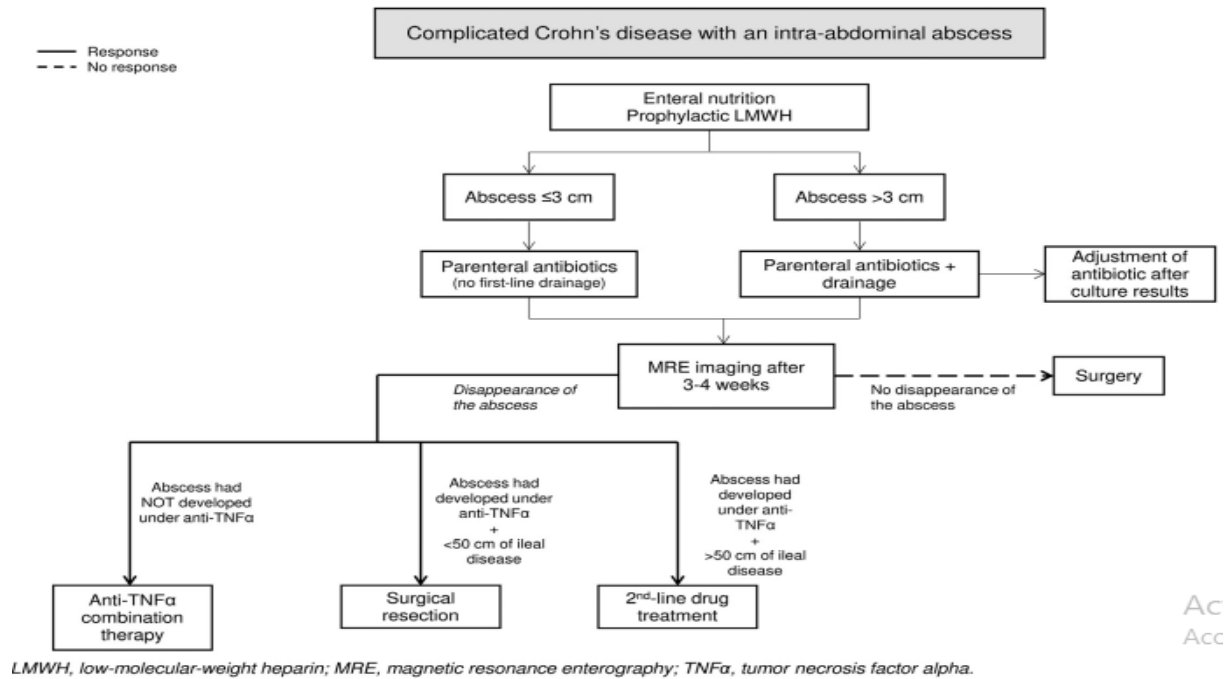


Figure 4 • Maladie de Crohn périnéale avec fistule simple. Algorithme thérapeutique de la phase aiguë d'une seule fistule basse, superficielle active, sans proctite ni abcès. TNFα, facteur de nécrose tumorale alpha.

Annexe : 07



Annexe : 08



Annexe : 09

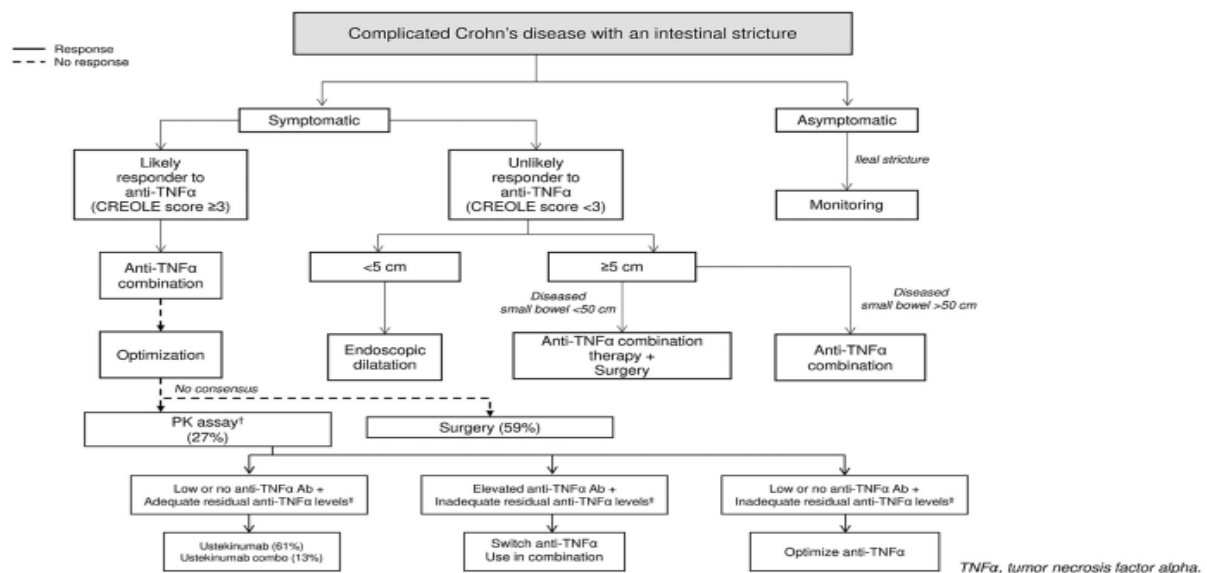
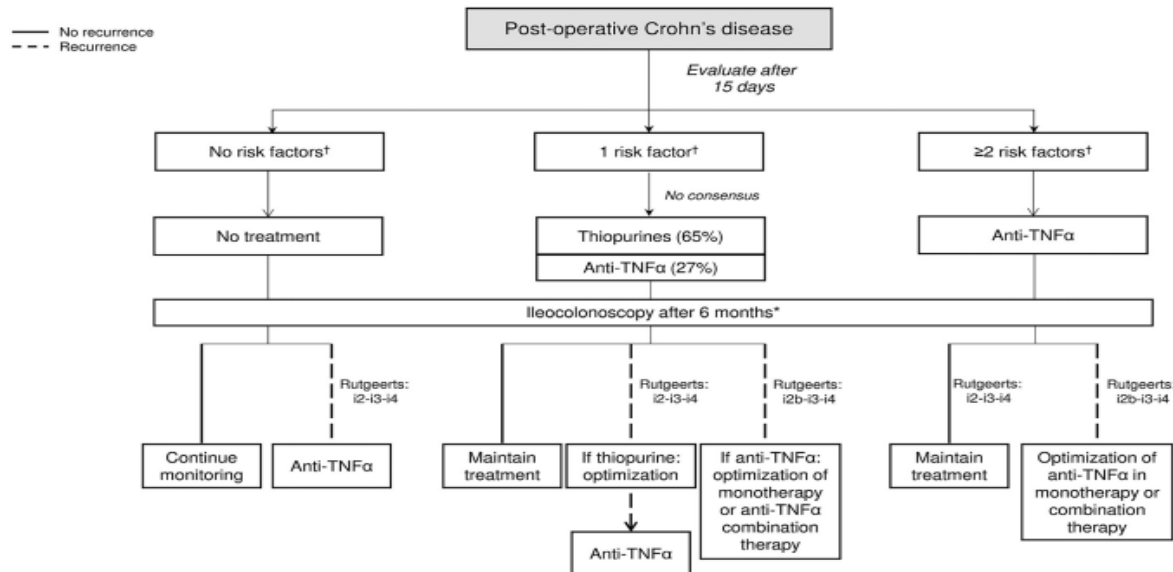
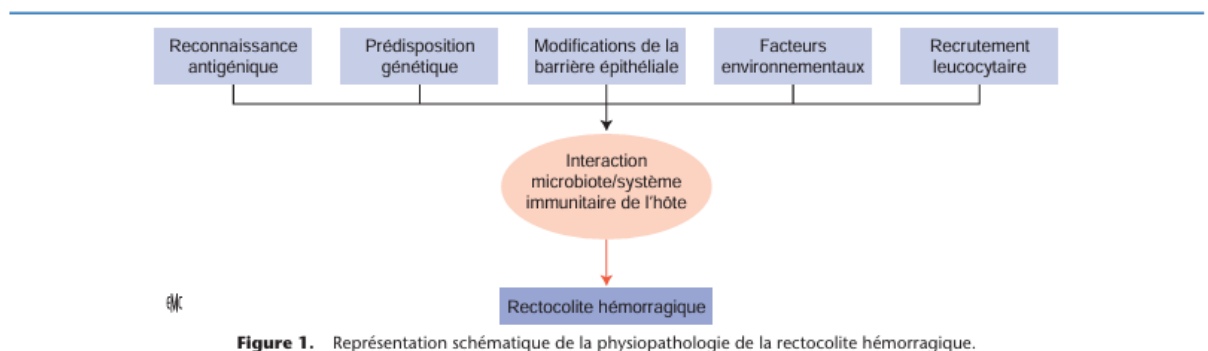


Fig. 4. Treatment algorithm for complicated Crohn's disease with an intestinal stricture
†In the absence of PK testing, ustekinumab is the alternative treatment in case of primary failure or when adverse event led to anti-TNFα discontinuation while no consensus was reached on the other scenarios.

Annexe : 10



Annexe : 11



Annexe : 12

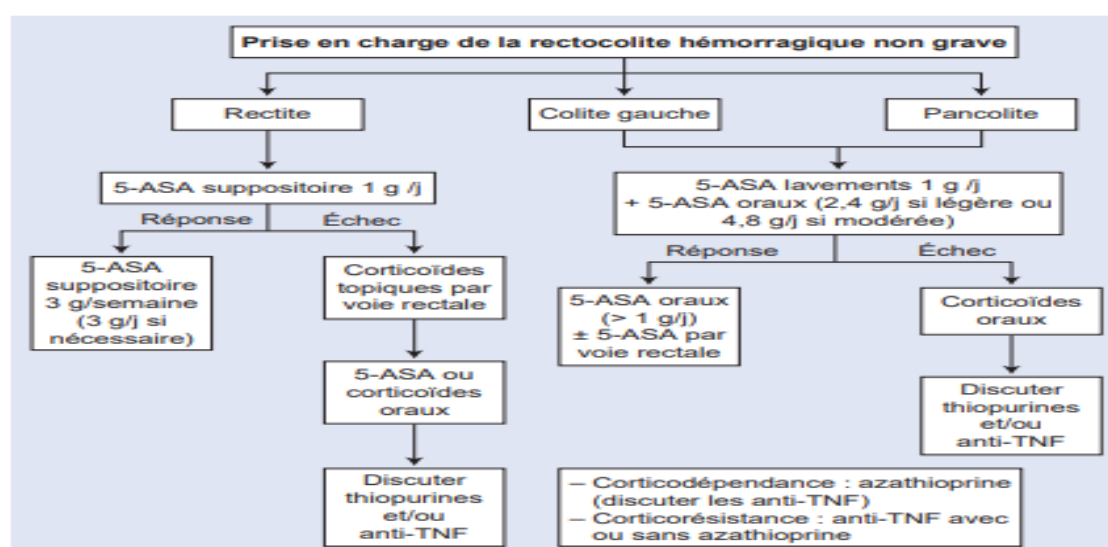
Critères de sévérité de Truelove et Witts.

	Légère	Modérée	Sévère
Nombre de selles	< 4	4 à 5	≥ 6 ET
Fréquence cardiaque	< 90	< 90	> 90 OU
Température (°C)	< 37,5	≤ 37,8	> 37,8 OU
Hémoglobininémie	> 11,5 g/dl	≥ 10,5 g/dl	< 10,5 g/dl OU
VS à la première heure ou CRP	≤ 20 mm/h normale	≤ 30 mm/h ≤ 30 mg/l	> 30 mm/h OU > 30 mg/l

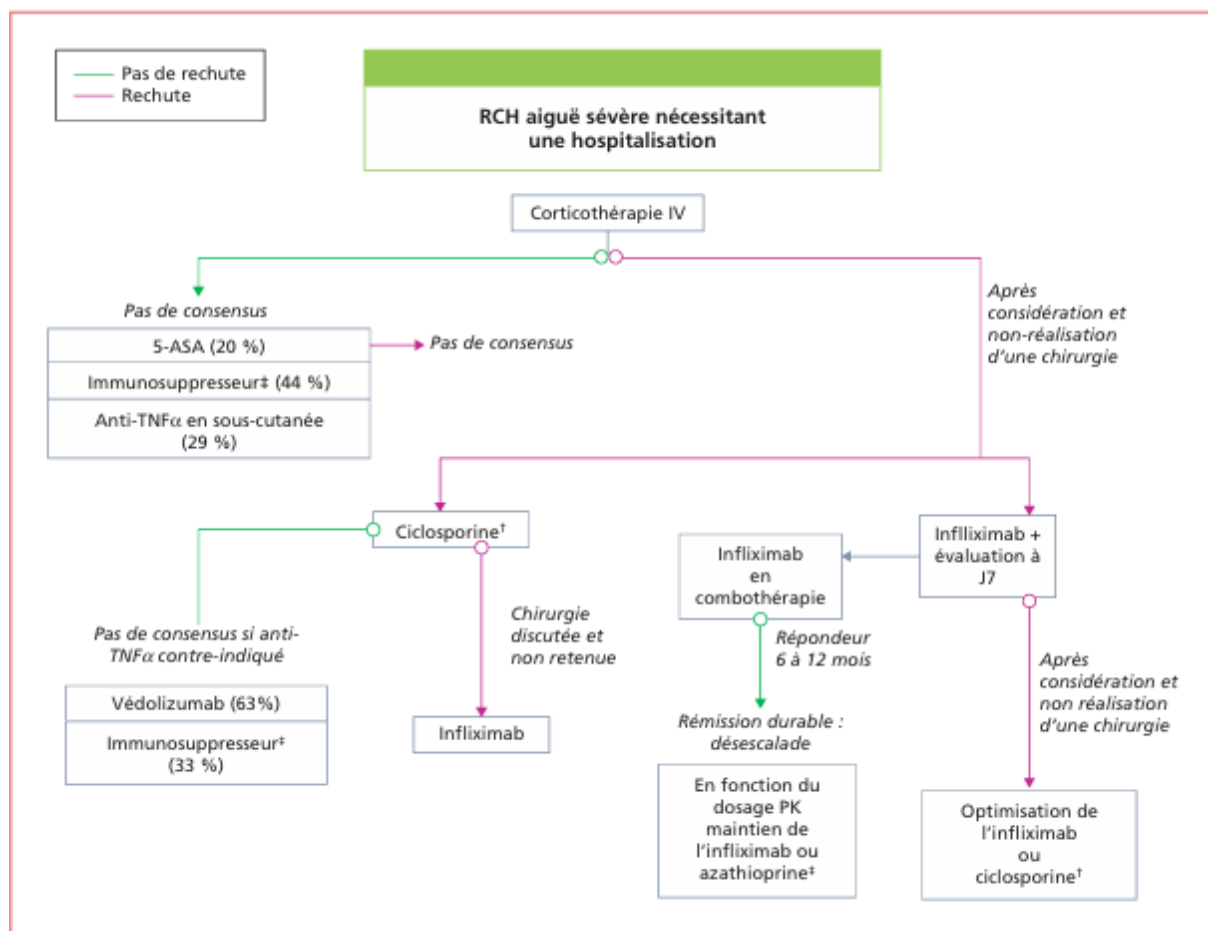
Annexe : 13

Indice de la Mayo Clinic	0	1	2	3
Sous-score de fréquence des selles (en plus du nombre habituel)	0	1 à 2	3 à 4	≥ 5
Sous-score de saignement rectal	Absent	< 50 % des émissions	> 50 % des émissions	Émission isolée de sang pur
Sous-score endoscopique	Aucune	Anomalies légères (érythème, diminution de la trame vasculaire, légère friabilité)	Anomalies modérées (érythème franc, disparition de la trame vasculaire, friabilité modérée, érosions)	Anomalies sévères (saignement spontané, ulcérations)
Évaluation globale du médecin	Normale	Légère	Modérée	Sévère

Annexe : 14



Annexe : 15



Annexe : 16